Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande - MS
Décima Segunda Vara Cível de Competência Residual

Autos nº 0802462-20.2019.8.12.0001
Ação: Procedimento Comum Cível
Autor:Lorenna Silva Oliveira
Réu:Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico

SENTENÇA

Vistos, etc.

1 – RELATÓRIO

Lorenna Silva Oliveira ajuizou(aram) a presente demanda em face de **Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico**, aduzindo, em resumo, que:

(**i**) é beneficiária de um plano de saúde empresarial junto à requerida;

(**ii**) em 17.01.2019, foi diagnosticada por seu cirurgião buco-maxilo-facial, como portadora de deficiência antero posterior de mandibula e excesso vertical de maxila, sendo indicado a realização de procedimento cirúrgico, consistente em osteoplastia de mandíbula para prognatismo e osteotomia;

(**iii**) a requerida não autorizou a cirurgia, obrigando a autora a assumir o pagamento do cirurgião, sendo a escolha do mesmo feito pela autora ante a inexistência de profissional cadastrado em seus quadros para realização da mesma;

(**iv**) requereu *tutela de urgência* para: que a requerida arque com os valores da cirurgia que já encontra-se agendada;

(**v**) requereu, ao final, a procedência da demanda para:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 02/12/2024 às 16:20 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802462-20.2019.8.12.0001 e código 37YuRHHi.

- confirmar a tutela, condenando a requerida a obrigação de fazer de arcar com a integralidade dos custos da cirurgia, inclusive honorários do profissional.

Com a inicial vieram documentos.

Despacho inicial às f. 41-46 ocasião em que a tutela de urgência foi negada, porém concedida pelo TJMS em sede de agravo de instrumento.

Devidamente citado, o ***requerido*** ofereceu *contestação* às f. 152-165, oportunidade em que sustentou:

(**i**) que não houve negativa ao procedimento, mas sim, quanto ao custeio dos honorários do profissional escolhido pela autora, que não faz parte do quadro de profissionais credenciados por se tratar de dentista – sendo o plano da autora exclusivamente hospitalar, sem cobertura odontológica, de forma que foi deferida a cobertura dos materiais e despesas hospitalares;

(**ii**) que não se tratava de quadro de urgência e emergência, sendo o tratamento de caráter eletivo e em caso de ressarcimento deverá ser observada a Tabela;

(**iii**) requereu a total improcedência da demanda; juntou documentos.

Impugnação à contestação às f. 227-233.

Decisão de *saneamento e organização do processo* às f. 252-255.

Laudo Pericial às f. 351-367.

A ***autora*** se manifestou às f . 371-372; a ***requerida*** às f. 373-374.

Houve a desistência da prova testemunhal por ambas as partes, sendo apresentadas as r*azões finais escritas* às f. 387-390 e 391-397.

É o relatório.

Fundamento e **DECIDO.**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 02/12/2024 às 16:20 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802462-20.2019.8.12.0001 e código 37YuRHHi.

2 – MOTIVAÇÃO

QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES

Não há questões pendentes a serem solvidas no presente caso.

DO MÉRITO

A relação havida entre as partes rege-se pelas regras da **Lei 8.078/90**, sendo a parte AUTORA considerada consumidora, *ex vi* do **art. 2°, do Código de Defesa do Consumidor**, que conceitua *"consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final"*, tratando-se de hipótese que há nítida condição de vulnerabilidade (**CDC 4º, I** – presunção *jure et de juris*).

Ademais, a parte REQUERIDA é considerada *fornecedora*, que, segundo o **art. 3°, do CDC**, *"fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços"*, sendo que *"produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial"* (**CDC 3º, § 1º**) e *"serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista"* (**CDC 3º, § 2º**).

Inclusive a questão foi devidamente pacificada pela Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual *"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde*".

Assim, a questão está amparada pela tutela consumerista e suas regras

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 02/12/2024 às 16:20 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802462-20.2019.8.12.0001 e código 37YuRHHi.

especiais.

Da obrigação de custeio do procedimento

Com efeito, ao contratar um plano de saúde, o consumidor tem como objetivo a segurança de que, no futuro, se necessitar de algum tratamento médico, será garantida a cobertura das respectivas despesas. Em contrapartida, despende mensalmente determinada quantia em favor da operadora do plano.

Logo, é imposição legal a interpretação do contrato de maneira mais favorável ao consumidor e a vedação de cláusulas abusivas, que coloquem em desequilíbrio a relação contratual.

Feitos estes esclarecimentos prévios, verifica-se que a vigência do contrato de plano de saúde e a negativa do custeio integral do procedimento são fatos incontroversos.

A autora afirma, em resumo, que obteve o diagnóstico de: "Deficiência antero posterior de mandibula e excesso vertical de maxila" e que estes diagnósticos "ocasiona dificuldade de mastigação e fonação, dor em região de articulação temporo mandibular esquerda e direita e alterações respiratórias" (fls. 2).

A autora pretendia, então, que a requerida custeasse os honorários do cirurgião dentista escolhido por ela, que a diagnosticou e que realizaria o procedimento recomendado: OSTEOPLASTIA DE MANDÍBULA PARA PROGNATISMO, OSTEOTOMIA tipo LE FORT I - Cod. AMB 3020805-0 e CID: K 07.2

Conforme Resolução n. 428/2017 da ANS vigente ao tempo dos fatos, procedimentos buco-maxilo-faciais podem ser cobertos pelos planos de saúde em determinadas circunstâncias:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 02/12/2024 às 16:20 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802462-20.2019.8.12.0001 e código 37YuRHHi.

> Art. 22. O Plano Hospitalar compreende os atendimentos realizados em todas as modalidades de internação hospitalar e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme Resolução específica vigente, não incluindo atendimentos ambulatoriais para fins de diagnóstico, terapia ou recuperação, ressalvado o disposto no inciso X deste artigo, observadas as seguintes exigências:
>
> VIII - cobertura dos procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais listados nos Anexos desta RN, para a segmentação hospitalar, conforme disposto no art. 5°, incluindo a solicitação de exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem, alimentação, órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de internação hospitalar;

Em relação a cobertura da equipe de profissionais de saúde há a seguinte previsão:

> IX – cobertura da estrutura hospitalar necessária à realização dos procedimentos odontológicos passíveis de realização ambulatorial, mas que por imperativo clínico necessitem de internação hospitalar, com equipe de saúde necessária à complexidade do caso, incluindo exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem e alimentação utilizados durante o período de internação hospitalar; e

Ainda, a Resolução n.465/2021 da ANS dispõe sobre a cobertura dos procedimentos o seguinte:

> Art. 22. O Plano Odontológico compreende a cobertura de todos os procedimentos listados no Anexo I desta Resolução Normativa para a segmentação odontológica.
> § 1º Os procedimentos bucomaxilofaciais que necessitarem de internação hospitalar não estão cobertos pelos planos odontológicos, porém têm

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 02/12/2024 às 16:20 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802462-20.2019.8.12.0001 e código 37YuRHHi.

cobertura obrigatória no plano de segmentação hospitalar e plano-referência.

§ 2° Nas situações em que, por imperativo clínico, o atendimento odontológico necessite de suporte hospitalar para a sua realização, apenas os materiais odontológicos e honorários referentes aos procedimentos listados no Anexo I para a segmentação odontológica deverão ser cobertos pelos planos odontológicos.

O procedimento requerido pela autora (OSTEOPLASTIA PARA PROGNATISMO) está incluído no anexo I, da Resolução acima citada como sendo CIRURGIA REPARADORA E FUNCIONAL DA FACE, de modo que é imperativo o custeio do procedimento pela requerida, considerando que a autora é titular do plano hospitalar.

Em consulta ao mesmo na presente data (novembro/2024), nota-se que "OSTEOPLASTIA PARA PROGNATISMO, MICROGNATISMO OU LATEROGNATISMO" é de cobertura obrigatória para plano hospitalar ambulatorial com cobertura obstetrícia, conforme consulta ao sítio eletrônico da ANS[1]:

Verificar cobertura de plano

Cheque aqui se um determinado procedimento faz parte da cobertura assistencial que seu plano de saúde é obrigado a cobrir.

Segmentação | Procedimento | Cobertura

Procedimento selecionado:

OSTEOPLASTIA PARA PROGNATISMO, MICROGNATISMO OU LATEROGNATISMO

Este procedimento é de cobertura obrigatória no tipo de plano informado.

Observação:

Note que a cobertura do procedimento pode depender de outros fatores, como data de contratação do plano, a preexistência da doença ou os prazos de carência.

O plano informado é da(s) segmentação(ões): Conforme o Rol de Procedimentos de Saúde definido pela ANS o procedimento citado é coberto por planos dessa(s) segmentaçao(ões).

Ainda com dúvidas? Acesse nossa seção de Central de atendimento.

Termo na TUSS:

Osteoplastia para prognatismo, micrognatismo ou laterognatismo

O laudo pericial concluiu que: "A cirurgia ortognática é uma opção no tratamento daqueles pacientes quepossuem deformidades dento-esqueléticas. Sendo a

[1] Disponível em: http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-do-consumidor/verificar-cobertura-de-plano

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 02/12/2024 às 16:20 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802462-20.2019.8.12.0001 e código 37YuRHHi.

postura do profissional plausível, observa-se planejamento adequado e coerente com a anomalia funcional que a requerente apresenta", sendo, ainda tal situação sido corroborada pela ausência de apresentação pela ré da existência de tratamento alternativo que fosse integralmente coberto e adequado para o tratamento da autora.

Portanto, mostra-se abusiva a recusa no custeio dos honorários do profissional que executaria o procedimento de cobertura obrigatória, afinal, os usuários são compelidos a aderir aos planos de saúde para ter assistência médica se e quando precisarem dela, e na medida necessária. Em contrapartida desta transferência de riscos futuros, os usuários pagam, de forma antecipada, regular e constante, determinada quantia de dinheiro.

Logo, considerando que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao aderente, entende- se, no caso presente, que os tratamentos demandados pelo autor e os materiais necessários devem ser custeados pela operadora do plano de saúde, porque indicados pelo responsável pelo paciente, não sendo dado ao plano de saúde, desse modo, interferir na técnica indicada.

LIMITAÇÃO DO CUSTEIO

Contudo, em que pese a obrigação de custeio integral do procedimento pela requerida, verifica-se que a parte autora exigiu a realização por pessoa que não faz parte dos quadros de credenciados ou conveniados da ré.

Deste modo, poderia a requerida apontar algum cirurgião apto que tivesse em seus quadros ou ainda rede conveniada de forma que, a restituição dos valores comprovadamente pagos pela autora para realização do procedimento, deve ser limitado a tabela efetivamente contratados com a operadora de saúde, pois é necessário respeitar os limites contratuais de custeio, com a finalidade de manter o equilíbrio da relação jurídica.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 02/12/2024 às 16:20 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802462-20.2019.8.12.0001 e código 37YuRHHi.

Destaca-se que a limitação de reembolso ao valor de tabela afasta qualquer possibilidade de enriquecimento indevido do usuário ao se utilizar de profissional ou hospital de referência que, em muitos casos, cobram valores muito superiores aos profissionais conveniados.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

> AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA INDEVIDA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE COLOCAÇÃO DE MARCA-PASSO - TRATAMENTO DE URGÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA OPERADORA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS NA INICIAL - INSURGÊNCIA DO AUTOR - AGRAVO INTERNO PROVIDO.
> 1. Depreende-se dos autos que: a) o procedimento cirúrgico de colocação de marcapasso era considerado imprescindível para o tratamento da enfermidade acometida pelo autor; b) a cirurgia era de ser realizada com urgência, pois a manutenção do quadro decorrente das arritmias acarretava risco à vida do paciente; e, c) a negativa de cobertura foi considerada indevida.
> 2. As alegações da parte ré, nas razões do recurso especial, segundo as quais o tratamento, supostamente sem conformidade técnica, teria sido realizado em rede não credenciada e fora da área de abrangência, bem ainda que o procedimento de colocação do marcapasso não estaria coberto diante de cláusula contratual expressa, refogem aos limites da moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, constituindo indevida inovação recursal.
> 2.1 Tais teses desbordam do objeto da análise a ser realizada por esta Corte Superior, pois, para tanto, seria necessário se imiscuir no quadro fático ensejador do conflito entre as partes, e, também, averiguar o conteúdo de cláusulas contratuais, mecanismos que a um só tempo ensejam inegável supressão de instância e violam os ditames das Súmulas 5 e 7/STJ.
> 3. Consoante entendimento sedimentado no STJ, o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário fora da rede credenciada somente pode ser admitido em hipóteses excepcionais, que compreendam a inexistência ou insuficiência de serviço credenciado no local - por falta de oferta ou em razão de recusa indevida de cobertura do tratamento -, bem como urgência ou emergência do procedimento,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 02/12/2024 às 16:20 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802462-20.2019.8.12.0001 e código 37YuRHHi.

observadas as obrigações contratuais e excluídos os valores que excederem a tabela de preços praticados no respectivo produto. [...]
5. Agravo interno provido para conhecer em parte do recurso especial da operadora do plano de saúde e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, mantendo a determinação das instâncias ordinárias quanto ao dever de reembolsar as despesas médico-hospitalares realizadas pelo autor, excluídos os valores que excederem os preços de tabela do plano, bem como os custos com hospedagem, transporte e alimentação, conforme contrato estabelecido entre as partes. (AgInt no REsp n. 1.933.552/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 25/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO MÉDICO FORA DA REDE CREDENCIADA. QUADRO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. REEMBOLSO NOS LIMITES DA TABELA DOS VALORES PAGOS. PRECEDENTES. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem consignou que, muito embora o atendimento médico tenha sido feito em hospital não pertencente à rede credenciada, configurou-se a hipótese de restituição limitada aos preços de tabela efetivamente contratados com a operadora de saúde.
Tendo a caracterização da situação de urgência e emergência sido feita com base na interpretação de fatos, provas e termos do contrato do plano de saúde, incidem as Súmulas 5 e 7/STJ sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional.
2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.043.025/MG, Rel Min. Marco Aurélio Bellizze, J. em 11/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚM. 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. REEMBOLSO DEVIDO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO AFASTADA. DANO MORAL. VALOR. PROPORCIONALIDADE. JULGAMENTO: CPC/73.
1. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c ressarcimento

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 02/12/2024 às 16:20 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802462-20.2019.8.12.0001 e código 37YuRHHi.

de despesas médicas e compensação por dano moral ajuizada em 23/05/2008, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 24/07/2012 e atribuído ao gabinete em 07/06/2017.
2. O propósito recursal é dizer, primordialmente, sobre: (i) a obrigação de a recorrente reembolsar, em dobro, as despesas contraídas pela recorrida para tratamento de saúde de emergência em hospital não credenciado; e (ii) o valor arbitrado a título de compensação do dano moral.
3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.
6. A jurisprudência do STJ orienta que é devido o reembolso em situações excepcionais, tais como: inexistência de estabelecimento credenciado no local; paciente em situação de urgência ou emergência; e impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada.
7. A obrigatória cobertura do atendimento em casos de urgência e emergência, como prevê o art. 35-C, I e II, da LPS, não implica, necessariamente, o seu custeamento integral pela operadora do plano de saúde, senão garante, salvo disposição em contrário, a restituição do que foi despendido pelo contratante, limitada, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, nos termos do art. 12, VI, daquela lei. 8.
No particular, a transferência da recorrida a hospital não credenciado, em outro estado, ainda que emergencial, implica-lhe o ônus financeiro de custear o pagamento das respectivas despesas, cabendo à operadora do plano de saúde o dever de reembolsar os valores nos limites do que foi estabelecido contratualmente.
9. Verifica-se, na espécie, que o Tribunal de origem presumiu a existência da má-fé da recorrente, o que, nos termos da jurisprudência do STJ, não se admite para o efeito de condená-la à repetição em dobro do indébito.
10. O valor arbitrado pelo Tribunal de origem - R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - não se mostra desproporcional ao dano moral sofrido pela recorrida em virtude da recusa indevida do plano de saúde em custear o procedimento cirúrgico e a remoção aérea para tratamento médico-hospitalar de emergência.
11. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp n. 1.392.560/PE, Rel. Minª Nancy Andrighi, J em 5/6/2018, DJe de 7/6/2018.)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 02/12/2024 às 16:20 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802462-20.2019.8.12.0001 e código 37YuRHHi.

Forte nessas razões, impõe-se o **acolhimento em parte** dos pedidos.

3 – DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do **art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil**, solvendo o mérito da controvérsia e pondo fim à fase cognitiva, **ACOLHO O PEDIDO DO AUTOR**, para:

I – **CONDENAR** o ***requerido*** ao custeio da cirurgia indicada à autora (material, despesas médico-hospital, etc), limitando, no que tange aos honorários do profissional, a Tabela do plano.

II – Com fundamento no **art. 85, e §§, e seguintes, todos do Código de Processo Civil**, e tendo em vista o julgado pelo **Superior Tribunal de Justiça** do **Tema Repetitivo nº 1.076** [*i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo*], **CONDENO, ante a sucumbência recíproca, AMBAS AS PARTES, na proporção de 50% para cada,** ao pagamento das **custas processuais** e **honorários**, sendo que estes últimos – atendido o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, a complexidade do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço – fixo em **10%** do valor da causa.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 02/12/2024 às 16:20 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802462-20.2019.8.12.0001 e código 37YuRHHi.

III – DELIBERAÇÕES FINAIS:

(i) se for o caso, nos casos de condenação de pagar (principal ou honorários), havendo o depósito nos autos, e concordando a parte contrária (ou silente), **desde já fica autorizado o levantamento dos valores**, independente de despacho, não devendo se proceder ao levantamento de eventual penhora/restrição derivada de outro processo sem expressa determinação deste juízo a propósito [caso em que deve ser certificado e imediatamente feita a conclusão do processo para deliberação].

(ii) se do julgado resultar na hipótese em que duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, fica autorizada a *compensação*, nos termos do art. 368 e seguintes, do Código Civil.

(iii) se concedida a assistência judiciária gratuita, a exigibilidade dos honorários e consectários legais em face da parte beneficiada fica suspensa.

(iv) se interposto RECURSO DE APELAÇÃO, a serventia deverá intimar o apelado [ou citá-lo para tanto, se ainda não tiver havido citação] para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (**CPC 1.010, § 1º**). Se o apelado interpuser apelação adesiva, intime-se o apelante para apresentar contrarrazões (**CPC 1.010, § 2º**). Após as formalidades, os autos deverão ser remetidos ao insigne Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade, sendo despicienda nova conclusão [exceto se for o caso de juízo de retratação, na forma do **art. 485, §7º, do Código de Processo Civil**].

(vi) cumpram-se as demais disposições pertinentes e aplicáveis à espécie previstas no Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Arquive-se.

Campo Grande, *data da assinatura digital*.

ATÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA JÚNIOR
JUIZ DE DIREITO – *ASSINATURA DIGITAL*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 02/12/2024 às 16:20 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802462-20.2019.8.12.0001 e código 37YuRHHi.